
QCM • CONCOURS

**Examen d'aptitude
professionnelle pour l'accès au
grade principal des cadres
relevant du corps des infirmiers
et techniciens de santé - 2ème
Epreuve**

Radiologie

Specialite : Radiologie

Annee : 2019

29 questions

Questions

1 L'os pariétal :

A	Est un os plat ;
B	Quadrangulaire ;
C	Pair ;
D	Symétrique.

2 L'os ethmoïdal :

A	Est un os court ;
B	Impaire ;
C	Médian ;
D	Symétrique.

3 L'os maxillaire :

A	Est un os plat ;
B	Pneumatique ;
C	Pair ;
D	Asymétrique.

4 La selle turcique correspond au(x) :

A	Apophyses ptérygoïdes ;
B	Corps du sphénoïde ;
C	Petites ailes du sphénoïde ;
D	Grandes ailes du sphénoïde.

5 Face latérale de l'os coxal comprend :

- A La face latérale de l'ilion ;
- B L'acétabulum ;
- C La fosse iliaque externe ;
- D La face interne du trou obturé.

6 Le calcanéum s'articule avec :

- A L'astragale et le scaphoïde ;
- B Le cuboïde et le scaphoïde ;
- C L'astragale et le cuboïde ;
- D Le cuboïde et le 1er cunéiforme.

7 La réduction des doses par les procédures radiologiques se fait par :

- A L'exclusion des examens non nécessaires ;
- B Le positionnement du patient en utilisant éventuellement des moyens de contention ;
- C La collimation du faisceau strictement à la région à examiner ;
- D L'utilisation des dispositifs de compression.

8 Les rayonnements électromagnétiques X et γ (photons) interagissent avec la matière selon :

- A L'effet photoélectrique ;
- B L'effet Compton ;
- C L'effet de matérialisation ;
- D Toutes les réponses sont fausses.

20 L'incidence du processus coronoïde (incidence en flexion) :

- A** Le patient est assis, coude fléchi à 90° ;
- B** Epaule, coude, poignet étant sur la même horizontale ;
- C** L'avant-bras et la main reposant sur leur bord ulnaire ;
- D** Rayon directeur centré à mi-distance entre l'épicondyle latéral et médial.

! Numbering jumps from 8 to 20 because page 2 of the original exam document is missing.

21 Incidence de la face du bras :

- A** Le patient debout, dos plaque, en légère oblique postérieur du coté à radiographier ;
- B** Membre supérieur en extension et légère abduction ;
- C** Main en pronation ;
- D** Rayon directeur horizontal vise le milieu du bras.

22 Parmi les critères de réussite de l'incidence de face de l'épaule -rotation indifférente ou neutre - :

- A** Le sillon intertuberculaire de projette en dedans ;
- B** Bon dégagement des interlignes gléno-huméral et acromio-huméral ;
- C** Superposition de la clavicule et de l'acromion ;
- D** Superposition des bords antérieur et postérieur de la glène.

23 L'incidence de profil -axillaire de l'épaule :

- A** Rayon directeur est incliné de 10° vers le coude ;
- B** Rayon directeur est incliné de 45° vers le coude ;
- C** Rayon directeur est centré à 5 cm en dedans de l'acromion ;
- D** Rayon directeur est centré à 1 cm en dedans de l'acromion.

24 L'incidence de profil de coiffe ou Lamy :

- A Rayon directeur horizontal ;
- B Rayon directeur incliné de 30° vers les pieds ;
- C Centré sur la fossette sous-acromiale ;
- D Centré sur le moignon de l'épaule.

25 L'incidence de trois quarts de la cheville avec étude de la malléole externe :

- A Rotation externe de 45° de la cheville ;
- B Rayon directeur vertical ;
- C Rayon directeur incliné de 15° vers la tête ;
- D Centré à un centimètre au-dessus de la malléole interne sur la ligne médiane à égale distance des deux malléoles.

26 L'incidence complémentaire du pied : interligne tarsométatarsien ou de Lisfranc :

- A Le patient en décubitus ;
- B Pied en flexion plantaire reposant sur la cassette par sa face dorsale ;
- C Talon incliné de 25° vers l'extérieur à partir de la verticale ;
- D Rayon directeur vertical centré sur le calcaneum.

27 Parmi les critères de réussite de l'incidence ¾ alaire bassin :

- A Les limites des trous obturateurs sont superposées ;
- B Les épines iliaques antérieure et postérieure sont superposées ;
- C L'aile iliaque est parfaitement exposée ;
- D La cotyle est vue de profil.

28 Le profil urétral de la hanche :

- A** Le côté à radiographier est soulevé de 45° ;
- B** Le côté opposé est soulevé de 45° ;
- C** Rayon directeur verticale vise le milieu du pli inguinal ;
- D** Rayon directeur verticale vise le milieu du pli inguinal côté opposé.

29 L'incidence de la rotule de face (incidence de Didier ou de Chaumet) :

- A** Rayon directeur ascendant de 30° ;
- B** Rayon directeur descendant de 30° ;
- C** Rayon directeur centré au milieu du creux poplité ;
- D** Rayon directeur centré au 2 cm au-dessus du creux poplité.

30 Technique de réalisation d'une radiographie thoracique standard :

- A** Le cliché thoracique doit être réalisé avec une distance focale (foyer-film) de 1 m ;
- B** On utilise la haute tension (120 à 140 kV) ;
- C** Temps de pose bref (1/100 sec) ;
- D** Inspiration profonde.

31 Le cliché réalisé afin de dégager les sommets pulmonaires :

- A** Le cliché en expiration ;
- B** Le cliché en lordose ;
- C** Le cliché en Valsalva ;
- D** Le cliché en décubitus latéral avec rayon horizontal.

32 La radiographie pulmonaire en incidence de Muller :

- A** Réalisée en décubitus latéral ;
- B** Prise en expiration ;
- C** Permet de préciser le caractère vasculaire ou tissulaire d'une opacité médiastinale ;
- D** Permet d'apprécier la mobilité des coupoles.

33 Parmi les critères de qualité du cliché thoracique de face :

- A** La symétrie ;
- B** La pénétration ;
- C** Le centrage ;
- D** L'inspiration profonde.

34 Les critères d'orientation du cliché thoracique de face :

- A** La poche à air gastrique du côté gauche ;
- B** La coupole diaphragmatique gauche est plus élevée par rapport à celle droite ;
- C** Le bouton aortique du cœur est au côté gauche ;
- D** Aucun critère d'orientation n'est possible.

35 La préparation du patient au transit œsogastroduodénal :

- A** A jeun 8 heures avant l'examen ;
- B** Vérifier qu'aucun examen baryté récent n'a été pratiqué ;
- C** Suppression de médicaments opaques (bismuth) et des pansements gastriques 3 jours avant l'examen ;
- D** Aucune préparation n'est nécessaire.

36 Les signes annonciateurs d'une réaction allergique au produit de contraste :

A	Un prurit ;
B	Une urticaire généralisée ;
C	Un angioedème ;
D	Une oppression thoracique.

37 L'hystérosalpingographie :

A	Permet l'exploration de la cavité utérine et les trompes ;
B	Indiquée pour un bilan d'infertilité primaire ou secondaire ;
C	Nécessite l'utilisation de la baryte ;
D	Est réalisée impérativement après la fin de la période menstruelle et avant la période pré-ovulatoire fertile.

38 Un traceur en médecine nucléaire :

A	Émet des $R \gamma$ susceptibles de détection ;
B	Est utilisé seul ;
C	Est une préparation de structures organiques caractéristiques d'une fonction physiologique ou métabolique ;
D	Sert à acheminer le marqueur vers l'organe à explorer.

39 Parmi les modalités d'acquisitions scintigraphiques :

A	Acquisition statique ;
B	Acquisition du corps entier ;
C	Acquisition tomographique ;
D	Acquisition dynamique.

40 La technique DSP en radiothérapie :

A	Consiste à placée la tumeur à l'isocentre de l'appareil de traitement ;
B	Consiste à positionner l'isocentre de l'appareil au point cutané par lequel pénètre l'axe du faisceau d'irradiation ;
C	N'est applicable qu'aux faisceaux uniques de protons ou d'électrons ;
D	La mieux adaptée à l'irradiation des tumeurs profondes par 2 à 4 faisceaux coaxiaux.

Notes d'extraction

- Page 2 of the original exam document (containing questions 9 to 19) is missing from the provided screenshots.